CHOC ANAPHYLACTIQUE AU BLOC OPERATOIRE
Grades ≥ II

CONFIRMER

- ❑ Hypotension, Chute de la capnie
- ❑ Tachycardie
- ❑ Bronchospasme
- ❑ Rash retardé, Angio-œdème
  (œdème laryngé, confusion avec œdème angioneurotique)
- ❑ ACR: cf. Aide Cognitive ACR

ELIMINER

- ❑ Embolie pulmonaire, amniotique
- ❑ IDM
- ❑ Pneumothorax, Obstruction trachéo-bronchique
- ❑ Surdosage en anesthésiques
- ❑ Hémorragie

INTERROMPRE l'administration du produit suspecté
APPEL À L'AIDE
STOP Chirurgie

TRAITER

- ❑ CONTRÔLE DES VOIES AERIENNES, OXYGENE PUR, VVP de bon calibre, TRENDELENBOURG
- ❑ REMPLISSAGE VASCULAIRE RAPIDE : cristalloïdes 500 ml si grade 2 et 1000 ml si grade 3, à renouveler 1 fois si besoin
- ❑ **ADRENALINE IVD (ampoule de 1 mg diluée dans 10 ml = 100 µg/ml pour PAM ≥ 60 mmHg**
  - Grade II : 20 µg puis 50 µg toutes les 2 min (attention double dilution de l'adrénaline dans ce cas)
  - Grade III : titration de 100 µg à 200 µg toutes les 1 à 2 min
  - Grade IV : boli d'adrénaline de 1 mg, cf. AC ACR
- ❑ EN CAS D'INEFFICACITE APRES 10 MINUTES
  - Doubler les Boli **d'ADRENALINE: 2 mg**
  - Adrénaline IVSE à débuter à 200 µg/h dès 3 boli IV administrés
  - **Noradrénaline** IVSE à débuter à 300 µg à 1 mg/h après 3 boli d'adrénaline
  - **Glucagon** 1 à 2 mg IVDL toutes les 5 min (si patient sous B-bloquant)
  - Poursuivre remplissage cristalloïde jusqu'à 30 ml/kg
  - Considérer monitorage non invasif de la volémie et /ou échographie cardiaque selon terrain
  - Discuter : **Vasopressine** 2 à 10 UI IVD puis poursuivre si besoin par perfusion de 2 UI/h
- ❑ EN CAS DE BRONCHOSPASME
  - Après correction de l'hypotension artérielle (le salbutamol pouvant la majorer)
  - Salbutamol en nébulisation (spray peu efficace dans la sonde d'intubation)
  - Salbutamol IVD : 100 µg à 200 µg (ampoule de 0,5 mg diluée dans 10 ml = 50 µg/ml), relais IVSE : 300 µg à 1,5 mg/h
- ❑ Prélèvements sanguins dès que possible
- ❑ Hémisuccinate d'hydrocortisone 200 mg IVDL (dose unique)
- ❑ En cas d'arrêt cardiaque réfractaire : envisager une assistance cardio-circulatoire ECLS/ECMO: (tél.....)

❑ **FEMME ENCEINTE** : discuter extraction fœtale immédiate si > 20 SA
- Décubitus latéral gauche
- Remplissage idem
- Adrénaline idem
- ACR : cf. AC ACR de la femme enceinte

APRÈS :
- ❑ Surveillance intensive au moins 6 h après disparition des signes
- ❑ Information du patient
- ❑ Prise de RV en Consultation d'allergo-anesthésie
- ❑ Déclaration Pharmacovigilance

Dosages	Tubes	<30min	1 à 2h	>24h
Histamine	EDTA	+	(+)	-
Tryptase	sec	+	+	+
IgE anti-AQ	sec	+	(+)	(+)

+ : recommandé ; **(+)** : si non réalisé au moment de la réaction.

Références: Outil SFAR. Prise en charge du choc anaphylactique. https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/07/Choc_Anaphylactique_SFAR_2010.pdf
RFE SFAR 2011, Prévention du risque anaphylactique per-anesthésique https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Prevention-du-risque-allergique-peranesthesique.pdf
Management of suspected immediate perioperative allergic reactions: an international overview and consensus recommendations. BJA2019;123(1):e50.

Réalisée en 2016 et mise à jour en 2022 par le CAMR